HCC-Fit 核查报告

演示（不联网） · 2026-10-30T14:41:51+0800 · visit_id：visit_1793342511_3c6df6

演示数据，不是真实论文结论。

1. 场景

目标人群	疾病：HCC；治疗：已接受切除；阶段：术前；已有资料：已有化验
要回答的问题	预测从手术日起一年复发
使用时点	pre_surgery
关心的结局	复发（12个月）
已有资料	已有化验
缺失资料	未填写

2. 判定

域内（肝癌相关） — 肝脏原发肿瘤（HCC）+ 与治疗决策相关 → 在域内（演示判定）

3. 综合结论

结论

- 人群匹配
- 时点不匹配
- 输入不可得

4. 四维核查

演示：未上传论文，使用内置示例（TACE 后 OS 评分） 档位：**不适用** 证据强度：中

维度	结论	理由 / 原文引文
人群	匹配	人群接近（演示）
时点	不匹配	模型需术后病理，当前为术前决策（演示）
输入	不匹配	必需变量不可得（演示）
结局	匹配	结局一致（演示）

5. 方案（不构成治疗建议）

方案	说明
先补齐关键数据，再做模型匹配（演示）	演示：当前没有可用模型，建议先补数据

6. 还缺什么数据

要补的	为什么	补齐可解锁
动脉期影像组学特征（4 项）	有 DICOM，可补；补齐后能解锁影像组学模型	1 个候选从“需补数据”→“可讨论”
病理 MVI 结果	术后模型的核心输入；术前无法获得，属于时间泄漏	术后场景下可评估
AFP-L3 / PIVKA-II	部分模型需要，当前未查	视具体模型而定

7. 我们不确定的事

- 本次未记录到显式不确定项，但仍需人工复核论文结论与适用边界。

8. 注意点

- 演示数据，不是真实论文结论
- 所有模型结论均需人工复核
- 不构成诊断或治疗建议

本结果仅用于临床决策前的证据准备，不构成诊断，不输出个体化概率，不替代多学科讨论与主治医师判断。

HCC-Fit · 仅用于临床决策前的证据准备 · 不作为诊断或治疗依据